

Diarrea aguda

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PONAP 2012, Consenso nacional

Dentro de la normalidad, las deposiciones pueden variar con la dieta y la edad del niño. En los tres primeros meses de edad el número de evacuaciones puede ser igual al número de ingestas, y la consistencia de las deposiciones en niños amamantados suele ser líquida, grumosa.

Teniendo en cuenta el patrón habitual de evacuación, se considera diarrea aguda el aumento de la frecuencia (mayor o igual a 3 deposiciones por día) y/o la disminución de su consistencia, que se prolonga por menos de 14 días.

Puede acompañarse de náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, y compromiso del estado general. Sus posibles consecuencias hidroelectrolíticas y nutricionales son las responsables de su morbimortalidad.

Epidemiología:

Diarrea aguda por Rotavirus:

- 6 a 11 meses: entre 40 a 50%
- entre 0 a 2 años fue de 25,5%,
- entre 2 a 5 años fue de 17,7%,
- en mayores de 5 años fue de 10,5%.

Mortalidad: durante el año 2010 las muertes por diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso en menores de 5 años fueron 70 niños.

En Argentina, el síndrome urémico hemolítico (SUH), como enfermedad posdiarreica en su forma típica, es *endémica*. *Representa la mayor incidencia en el mundo con un reporte de 15 casos/100.000 niños menores de 5 años. Se presentan más de 400 nuevos casos cada año.*

Etiología:

Viral:

- Generalmente afecta lactantes y niños pequeños
- Sobre todo en época otoñal
- De comienzo brusco, con vómitos y fiebre que preceden en varias horas al comienzo de las deposiciones diarreicas.
- Transmisión: Fecal – oral y Respiratoria
- *Rotavirus*
 - Es el agente etiológico más frecuente en niños menores de 3 años
 - Se sospecha en niños con diarrea aguda con fiebre, vómitos y cuadro respiratorio
 - Es frecuente en infecciones intrahospitalarias.
- *Adenovirus*
 - Presenta menos fiebre y mejor estado general
- *Astrovirus*
 - Se presenta con vómitos menos severos y cuadro clínico de duración más corta
- *Norovirus*
 - Se *presenta* con importantes vómitos pero con menos fiebre y diarrea más leve

Bacteriana:

- Más frecuente verano
- Niños mayores
- Con condiciones deficitarias de higiene personal, ambiental o alimentaria.
- Transmisión: Fecal – oral (agua y alimentos contaminados)

Clínica sugerente:

- Fiebre alta que puede ser mayor o igual a 40 °C
- Sangre y moco en la materia fecal, causada por bacterias invasivas
- Dolor abdominal
- Compromiso SNC cuando el agente etiológico es *Shigella* (por la liberación de neurotoxina).
- Los cuadros diarreicos, asociados a contaminación alimentaria por toxina estafilocócica dan síntomas precoces luego de la ingesta, con pronta recuperación

Diarrea aguda con sangre:

- Su sola presencia no significa mayor riesgo o mal pronóstico
- Los pacientes deben ser controlados cada 24 horas para la pesquisa precoz de complicaciones, como SUH o disentería grave
- 1. Indicar dieta y recomendaciones y pautas de alarma como en cualquier diarrea
- 2. Solicitar Hemograma (observando el hto y número de plaquetas) y función renal.
- 3. Solicitar RMN para diferenciar si es debido a colorantes, si los GR so más de 5/campo:
- 4. Solicitar Coprocultivo
- 5. Según resultado:
 - Shigella: con ATB se cura + rápido y evito que contagie a otros: Ceftriaxona o Fosfomicina
 - Campylobacter: indicar ATB
 - Escherichiacoli ST: no se indica ATB ya que podría favorecer el S.U.H.
 - Salmonella: debería esperar que se autolimite ya que los ATB pueden favorecer su persistencia
 - Entamoebahistolytica: el metronidazol acelera la cura

Antibióticos para shigellosis (SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA 5º Congreso Argentino de Pediatría General Ambulatoria)

Ciudad de Buenos Aires 17 al 20 de noviembre de 2010

- Ceftriaxona IM: 50 mg / kg , 2 dosis (TJP: Eidlitz-Marcus 11 / 93) 5 días (RB, 27ed, 07)
- Azitromicina: 10 mg/kg 1 dosis, 3 días (PIDJ: Basualdo 4/ 03, Miron 4 / 04) o 5 días (RB, 27ed)
- Ciprofloxacina: 15 mg/Kg, 2 veces por día , 3 días (PIDJ, D.S.G.12 / 02, Guías OMS 2005)
- Más Zinc < 6 m. 10 mg/día > 6m: 20 mg/día. 14 días
- Las cefalosporinas orales son inútiles (limitada eficacia cefixima)

Parasitaria:

- Si bien se asocian a diarrea prolongada, pueden dar episodios de diarrea aguda.

Mecanismos básicos generadores de diarrea aguda

1. Aumento de la secreción intestinal de electrolitos

- Heces con gran volumen acuoso y elevadas pérdidas electrolíticas
- Generan deshidratación hiponatémica
- Se produce por efecto de enterotoxinas bacterianas que activan la adenilciclase del epitelio intestinal, produciendo aumento de la concentración de AMP cíclico, incrementando la secreción activa de líquidos y electrolitos
- Ejemplo:
 - *Vibrio cholerae*
 - *Escherichia coli* Enterotoxigenica
 - *Shigella*
 - *Salmonella*
 - *Estafilococcus*
 - *Clostridium perfringes*.
 - La *Yersinia enterocolítica*, las *Aeromonas* y *Rotavirus* también pueden producirla

2. Reducción del área de superficie absorptiva

- Hay lisis de los enterocitos de las vellosidades intestinales por agresión viral directa o por citotoxinas o adhesión de bacterias, dejando a las células de las criptas en mayor proporción.
- Por lo general hay lesión de la mucosa es en parches, por lo que el intestino sigue absorbiendo nutrientes.
- Hay alteración en la absorción principalmente hidratos de carbono, produciendo gran arrastre de agua hacia la luz intestinal.
- Frecuentemente se produce déficit de lactasa por el cual la lactosa no digerida ni absorbida atrae agua hacia la luz intestinal, que son metabolizados por las bacterias intestinales con producción de ácidos orgánicos y gas presentando como consecuencia diarrea acuosa, si

bien con bajo contenidos de sales, puede generar deshidratación, y deposiciones ácidas causando eritema perianal, gases y cólicos.

- Ejemplo:
 - *Rotavirus*
 - *Escherichia coli* Enteropatógena
 - *Escherichia coli* Enterohemorrágica
 - *Cryptosporidium parvum*
 - *Giardia lamblia*.

3. Invasión de la mucosa y submucosa del colon e íleon terminal

- La acción de bacterias invasivas provoca inflamación, alteración de la permeabilidad con hemorragia, formación de microabscesos y ulceración
- La absorción de agua a nivel de colon está disminuida y el proceso inflamatorio aumenta la motilidad produciendo deposiciones frecuentes, escasas, con pujos y tenesmos,
- Puede contener moco y/o sangre, conformando un síndrome disentérico.
- Ejemplo:
 - *Shigella*
 - *Escherichia coli* Enteroinvasiva
 - *Entamoeba histolytica*
 - Más raramente *Salmonella*, *Campylobacter Yeyuni* y *Yersinia enterocolítica*.

Verotoxina: es la toxina que está asociada a la presentación de SUH, producida por cepas de *Escherichia coli* Enterohemorrágica, productora de toxina Shiga. Otros gérmenes también han sido asociados a casos de SUH, como *Shigella dysenteriae* tipo 1, *Campylobacter sp.* y *S. pneumoniae*, entre otros.

- Debe sospecharse en niños con diarrea con sangre, palidez, irritabilidad, vómitos, convulsiones y oligoanuria o anuria. Luego de un período prodrómico de 3 a 7 días de diarrea, con sangre
- En el 75% de los casos, aparece el compromiso de los dos sistemas más afectados:
 - Sangre: anemia microangiopática con hematíes fragmentados y trombocitopenia
 - Riñón: anuria u oligoanuria.
- El 50% de los niños tienen hipertensión arterial en esta etapa.
- En el 30% de los casos puede haber compromiso neurológico con alteraciones de la conciencia hasta convulsiones y coma
- La orina muestra siempre hematuria, por lo que es importante, ni bien ingresa el paciente, recolectar orina, ya que puede ser la última antes de entrar en anuria.

Laboratorio:

- Hematuria, cilindruria y proteinuria
- Aumento de urea, potasio, acidosis metabólica
- En el frotis en sangre hematíes fragmentados esquistocitos y trombocitopenia.

Anamnesis

- Tiempo de evolución
- Número, volumen y característica (consistencia y color) de las deposiciones
- Presencia de moco y/o sangre en las heces.
- Temperatura corporal
- Vómitos: número, volumen y característica: gástricos, alimentarios, biliosos.
- Tipo y cantidad de líquidos aportados.
- Color y volumen de orina.
- Alteraciones del sensorio: tendencia al sueño, letargo, etc, que generalmente se asocia a deshidratación hiponatrémica
- Compromiso neurológico.
- Tipo de respiración: respiración rápida y superficial frecuente (en acidosis metabólica).
- Alimentos que recibió. Apetito.

- Si recibió algún tratamiento (medicación sintomática, antibióticos, ácido acetil salicílico, tóxicos, infusiones caseras, etc.).
- Antecedente de viaje reciente, internación, u otros afectados en el entorno (ejemplo: hogar, escuela, jardín, comedor, etc.).
- Antecedentes de enfermedades previas

Examen físico:

Priorizar:

- Estado de hidratación,
- Semiología abdominal,
- Estado nutricional,
- Estado toxi-infeccioso.

	A	B	C
1. PREGUNTE Sed Orina	Normal.Norma	Más de lo normal. Poca cantidad, oscura.	Excesiva. No orinó durante 6 horas.
2. OBSERVE Aspecto Ojos Boca y lengua Respiración	Alerta. Normales,Húmedas Normal.	Irritado o decaído Hundidos Secas Más rápida de lo normal	Deprimido o comatoso.* Muy hundidos, llora sin lágrimas. Muy secas, sin saliva Muy rápida y profunda
4. EXPLORE Elasticidad de la piel Fontanela Pulso Llenado capilar	El pliegue se deshace con rapidez. Normal. Normal. < 2 segundos.	El pliegue se deshace con lentitud. Hundida Se palpa Más rápido de lo normal. De 3 a 5 segundos.	El pliegue se deshace muy lentamente: más de 2 segundos. Muy hundida, se palpa y se observa Muy rápido, fino o no se palpa. Mayor de 5 segundos.*
4. DECIDA	No tiene deshidratación.	Si tiene dos o más síntomas o signos, tiene deshidratación.	Si tiene dos o más de estos síntomas o signos: tiene deshidratación grave. Si tiene uno o más de los signos marcados con * tiene deshidratación grave con shock hipovolémico.
5. TRATAMIENTO	Aplique Plan A para prevenir la deshidratación.	Aplique Plan B para tratar la deshidratación.	Plan C Comenzar EV: • Si hay shock. • Si hay vómitos incoercibles (abundantes o más de 4 en una hora). • Si hay íleo. • Si hay convulsiones.

Criterios de internación:

- Signos de shock,
- Alteración del sensorio
- Estado toxi-infeccioso
- Severa deshidratación con signos clínicos de hiper o hiponatremia y acidosis metabólica
- Abdomen distendido y doloroso a la palpación
- Vómitos biliosos o incoercibles
- Anuria o poca diuresis
- Fracaso de hidratación oral.